# 2.1.4.1. 환자정보 공유 및 인수인계(전과, 전동, 근무교대)

| 제 정 일 | 2006.07. | 최 종 개 정 일 | 2025.03.25. | 최 종 검 토 일 | 2025.03.25. |
|---|---|---|---|---|---|
| 담 당 부 서 | 의료질향상 및 환자안전위원회 | | | | |
| 유 관 부 서 | | | | | |

| 관 련 기 준 | 4주기 의료기관인증기준: 2.1.4 환자진료의 일관성 및 연속성 유지<br>JCI Standard 7th Edition: IPSG.2, 2.2, ACC.3, 3.1 |
|---|---|

제1조 (목적)

1. 진료의 일관성 및 연속성을 유지하기 위하여 진료에 대한 책임자를 정하고, 환자의 문제를 해결하기 위해 일관된 절차에 따라 진료를 제공하고 표준화된 의사소통 과정을 통해 정보를 공유하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 전과(Intra-department transfer): 진료과와 진료과 간의 이동
2. 전동(Transporting patients between wards): 병동 간, 병동/중환자실/응급진료센터 간의 환자 이동
3. 인수인계(Handover): 환자 치료의 일부분 또는 전체의 책임을 일시적 또는 영구적으로 다른 의료진이나 부서로 이전하는 것

제3조 (절차)

1. 환자 진료에 대한 책임
   1) 입원을 처방한 의사는 환자 진료를 책임지는 의사이다.
   2) 환자 진료에 참여하고 권한을 가진 주치의(담당교수)는 전반적인 진료 및 의무기록에 대한 책임이 있다.
   3) 환자 및 보호자에게 환자 치료에 대한 정보를 제공할 책임이 있다.
   4) 주치의(담당교수)에 대한 정보, 주치의(담당교수) 변경 등의 정보를 관련직원, 환자 및 보호자와 공유한다.
   5) 주치의(담당교수)는 담당의사(전공의)를 지도, 감독하며 의무기록을 확인한다.

2. 환자 담당 의료진 변경
   1) 전과
      (1) 환자의 의학적 상태에 대한 향후 치료를 목적으로 적절한 타 진료과에 전과를 위한 협의진료를 요청(협의진료의뢰서)한다.
      (2) 협의진료를 요청받은 진료과는 진료정보를 파악하여 요청한 진료과와 협의 하에 전과를 결정한다.
      (3) 전과 결정이 되면 전과를 요청한 의사는 전출 처방 입력 전까지 필수 환자정보를 요약한 전출기록지(Transfer Out Note)를 작성한다.
      (4) 전입을 받는 의사는 전입 후 24시간 이내 필수 환자정보를 요약한

전입기록지(Transfer In Note)를 작성한다.

(5) 전출 및 전입기록에는 환자 기본정보, 전출/전입 시점에서의 환자 상태 및 치료 경과, 필요 시 제공되는 장비 및 기구 등을 기록한다.

(6) 전과로 인한 주치의(담당교수) 변경 시 전출 및 전입 기록지를 통해 관련 직원과 정보를 공유하며, 환자 및 보호자에게 주치의(담당교수) 변경사실에 대해 설명한다.

2) 진료과 내 주치의(담당교수) 변경

(1) 주치의(담당교수)는 인계를 받는 의사에게 환자의 치료에 대한 정보를 제공할 책임이 있다.

(2) 같은 진료과 내에서 주치의(담당교수)가 변경되는 경우 변경된 주치의(담당교수)는 주치의(담당교수) 경과기록 작성 또는 환자 경과 및 평가 내용을 확인하고 관련 기록을 Co-sign한다.

(3) 인계 받은 주치의(담당교수)는 환자상태에 대해 책임을 진다.

(4) 의무기록을 통해 관련 직원과 정보를 공유하며, 환자 및 보호자에게 주치의(담당교수) 변경사실에 대해 설명한다.

(5) 이는 주치의(담당교수) 부재(출장, 학회 등)시에도 동일하게 적용된다.

3) 담당의사(전공의) 변경(Term Change)

(1) 같은 진료과 내에서 담당의사(전공의)가 변경되는 경우 인수기록과 인계기록을 작성한다.

(2) 인수인계 기록에는 환자 기본정보, 인수인계 시점에서의 환자 상태 및 치료 경과, 필요시 제공되는 장비 및 기구 등을 기록한다.

(3) 인계기록은 환자 인계 전, 인수기록은 환자 인계 후에 기록한다.

4) 전동

(1) 환자상태 변화 및 요구를 파악하여 필요한 경우 의료진은 전동을 결정한다.

(2) 환자를 보내는 부서는 환자를 받는 부서에 필수 환자정보를 간호사 인수인계, 임상관찰기록, u-Severance 간호기록 등을 이용하여 인수인계 한다.

(3) 인수인계 상황에서 인계되는 필수 환자정보에는 다음을 포함한다.

① 환자 기본정보(이름, 등록번호) / 진단명, 제공된 진료내용(수술/시술명, 고위험의약품 등)

② 인계시점의 환자상태(낙상위험, 중증도 등)

③ 제공되는 장비 및 기구(모니터 장비, 산소 및 흡인 장비, 약물 주입펌프 등)

④ 치료계획(예정된 수술, 시술, 검사 등)

(4) 환자를 보내는 부서는 간호기록 프로토콜 'Transfer–퇴실'을 이용하여 환자확인, 환자 상태, 이동사유, 이동방법, 이동병실, 동행자 등을 기록한다.

(5) 환자를 받는 부서는 간호기록 프로토콜 'Transfer–입실'을 이용하여 환자확인, 환자 상태, 이동사유, 이동방법, 동행자, 장비 및 기구, 삽입관 여부, 입실동의서(중환자실)등을 기록한다.

(6) 전동 시 의료진의 동반이 요구되는 환자 상태는 세브란스병원 내규 [2.1.4.2. 환자 원내 이송]에 따른다.

3. 근무교대

1) 간호사 근무교대 시
   (1) 필수 환자정보를 간호사 인수인계, 임상관찰기록, u-Severance 간호기록 등을 이용하여 인수인계 한다.
   (2) 인수인계 상황에서 인계되는 필수 환자정보에는 다음을 포함한다.
      ① 환자 기본정보(이름, 등록번호) / 진단명, 제공된 진료내용(수술/시술명, 고위험의약품 등)
      ② 인계시점의 환자상태(낙상위험, 중증도 등)
      ③ 제공되는 장비 및 기구(모니터 장비, 산소 및 흡인 장비, 약물 주입펌프 등)
      ④ 치료계획(예정된 수술, 시술, 검사 등)
2) 담당의사(전공의) 당직 시: 필수 환자정보 및 주요 전달사항을 구두 및 서면으로 인수인계 한다. 환자 상태가 급격히 변화하였을 경우 환자 상태 및 처치 내용을 경과기록에 작성한다.

4. 수술실 이동시 인수인계
   1) 수술 전: 처치 및 간호상태 기록지를 이용하여 인수인계 한다.
   2) 수술 후: 회복실 기록지, 수술간호기록 등을 이용하여 인수인계 한다.
   3) 필요 시 주요사항은 유선으로 연락한다.

5. 환자 상태변화 시 보고 체계
   1) 인수인계 받은 의료진은 환자상태를 파악한다.
   2) 환자상태 변화 시 담당 의료진은 진료과별 보고체계에 따라 보고한다.
   3) 진료과별 보고체계에는 다음의 내용을 포함한다.
      (1) 보고자, 보고 범위
      (2) 주간정규시간, 야간, 공휴시간에 보고받는 1차 담당자
      (3) 보고가 원활하지 않을 때 백업 호출할 수 있는 2차 담당자
   4) 응급실, 중환자실 등 특수 부서는 보고체계가 상이할 수 있다.

6. 인수인계 의사소통 관련 위해사건(Adverse events) 데이터를 관련 질향상 및 환자안전 활동에 활용한다.

7. 진료의 연계와 조율
   1) 의료기관은 환자 진료와 관련된 각 부서 간/의료진 간의 연계와 조율을 위해 노력한다.
   2) 의료진은 의무기록을 통해 정보를 교환하며, 환자 진료와 관련된 기록은 최신의 내용으로 유지한다.
   3) 의료진은 의무기록의 Smart Viewer를 이용하여 환자의 최신 요약정보를 확인하고 진료의 연속성을 유지한다. Smart Viewer에는 주요 진단, 약물 알레르기, 현재 복용하는 약물, 외과적 시술 병력, 입원병력 등의 정보가 포함된다. Smart Viewer에서 제공되는 정보는 의료진의 요구에 따라 변경할 수 있다.
   4) 환자 진료와 관련된 표준진료지침이 존재하는 경우 관련 의료진은 표준진료지침에 따라 계획된 진료를 시행한다.

제4조 (부록)

제5조 (참고)

## 내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2006년 7월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인 : 세브란스병원장 이 강 영 (인)